

Deficyty *poznawcze*

75–85% pacjentów z psychozą ma trudności z pamięcią, uwagą, planowaniem. To silniejszy predyktor funkcjonowania niż objawy pozytywne — a często niezauważany.

CZAS: 15 min · psychoedukacja + plan Po stabilizacji · powrót do nauki/pracy

ŹRÓDŁO: Wykes & Reeder (2005, CRT); Green (1996, 2006); MATRICS Initiative (2008)

JAK UŻYWAĆ

Rozpoznaj **pięć domen** funkcjonowania poznawczego, które najczęściej są upośledzone (sekcja 1), zrozum różnicę między **treningiem poznawczym** a **strategiami kompensacyjnymi** (sekcja 2) i wybierz **trzy strategie** do wprowadzenia w tygodniu (sekcja 3).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Green (1996, 2006): deficyty poznawcze są **silniejszym predyktorem funkcjonowania społecznego i zawodowego** ($r = 0,4-0,6$) niż objawy pozytywne — pacjent może *nie mieć* urojeń, a wciąż nie pracować, nie uczyć się, bo nie nadąża. Wykes i in. (2011, meta-analiza 40 RCT): terapia remediacji poznawczej (ang. *Cognitive Remediation Therapy*, CRT) poprawia funkcje poznawcze ($d = 0,45$) i funkcjonowanie codzienne ($d = 0,42$). Najlepiej działa, gdy jest **zintegrowana z rehabilitacją zawodową** — trening poznawczy w kontekście pracy ma większy transfer niż ćwiczenia w odizolowaniu.

01 Pięć domen najczęściej upośledzonych

PAMIĘĆ ROBOCZA

Trudność z utrzymaniem informacji „w głowie” podczas wykonywania zadania. Zapominasz w połowie zdania, co chciałeś powiedzieć.

UWAGA

Trudność z dłuższą koncentracją, łatwa rozpraszalność. Trudniej skupić się w hałasie, w tłumie, przy wielu bodźcach naraz.

SZYBKOŚĆ PRZETWARZANIA

Wszystko wymaga więcej czasu — czytanie, podejmowanie decyzji, reagowanie. Nie głupota — wolniejsze przetwarzanie.

FUNKCJE WYKONAWCZE

Planowanie, elastyczność, hamowanie impulsów. Trudność z rozpoczynaniem zadań, przerywaniem w połowie, zmianą kierunku.

POZNANIE SPOŁECZNE

Trudność z odczytywaniem emocji z twarzy, intencji innych, kontekstu rozmowy. To nie obojętność — to specyficzny deficyt percepcji społecznej, dobrze udokumentowany w schizofrenii.

02 Trening vs strategie kompensacyjne

TRENING — CRT

Strukturyzowane ćwiczenia 2-3×/tydz., przez 3-6 mies. Komputerowe lub papierowe. Cel: *poprawa* samej funkcji. Wykes (2011): $d = 0,45$.

KOMPENSACJA — STRATEGIE

„Okulary dla mózgu” — listy, alarmy, rutyna, kalendarz. Cel: *obejście* deficytu, nie jego usunięcie. Działa od pierwszego dnia.

03 Strategie kompensacyjne — co realnie pomaga

LISTA ZADAŃ PISEMNA

Nie w głowie — na kartce, w telefonie. Pamięć robocza nie musi tego trzymać. Wykreślanie daje też satysfakcję.

KALENDARZ + ALARMY

Każde spotkanie, każdy lek, każda wizyta — w kalendarzu z alarmem 1 godzinę wcześniej. Telefon przejmuje pamięć epizodyczną.

RUTYNA

Te same czynności o tych samych porach. Mózg nie musi *decydować* o każdym kroku — działa na autopilocie.

UPROSZCZONE ŚRODOWISKO

Mniej bodźców, czyste biurko, jedna rzecz naraz. Nie odpowiadaj na SMS w trakcie pracy. Bodźce konkurują o uwagę.

KRÓTKIE BLOKI + PRZERWY

25 min pracy + 5 min przerwy (technika Pomodoro). Mózg nie utrzymuje uwagi przez godziny. Akceptuj swoje granice.

POWTARZANIE I ZAPISYWANIE

Po rozmowie z lekarzem — zapisz najważniejsze. Po lekcji — notatki. Nie ufaj pamięci roboczej, ona nie wystarczy.

04 Moje trzy strategie na ten tydzień

Wybierz **trzy** z sekcji 3, które chcesz wdrożyć od jutra. Nie wszystkie naraz — trzy realne zmiany lepiej niż dziesięć planów.

STRATEGIA 1

— co i kiedy

STRATEGIA 2

STRATEGIA 3

Klucz: deficyty poznawcze to *niewidoczna niepełnosprawność* w psychozie. Otoczenie często widzi tylko „*nie próbuje*”, „*nie pamięta o spotkaniach*”, „*nie nadąża*” — i interpretuje jako brak motywacji. Green (2006): to nie wybór, to objaw. Strategie kompensacyjne to nie „*oszukiwanie*” — to mądre zarządzanie zasobami mózgu. Bateria MATRICS (ang. *Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia*) — standardowe narzędzie oceny, którym dysponują kliniki rehabilitacji poznawczej. Warto poprosić o ocenę funkcji poznawczych jako część planu leczenia.